



3

53. ÅRGANG | 03 • 2016

ARTIKEL

PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK TIDSSKRIFT
FORLAGET SKOLEPSYKOLOGI • PÆDAGOGISKE PSYKOLOGERS FORENING

Indhold

Motiverende mobilteknologi i skole-hjemsamarbejdet – betydning og implementering

Inklusion – en proces på mangfoldige niveauer

Skriv med glæde – få mere lystbetonede og fleksible skriveprocesser

At styrke forbindelser – Evaluering af et kompetenceudviklingsforløb

Danske elevers opfattelse af fredsundervisning

Indretning af daginstitutioner som bo-grupper

Hvordan kan der skabes motivation og trivsel hos udsatte unge gennem træning af resiliens?

Debatindlæg: Er ADHD, en neurologisk forstyrrelse, en social konstruksjon eller kan det være både-og?

PPR og skolens samarbejde med forældrene

Mindeord for Anders Poulsen

Debatindlæg: Er ADHD, en nevrologisk forstyrrelse, en sosial konstruksjon eller kan det være både-og?



I vårt samfunn har ADHD blitt en av de største barnesykdommene. Medisinbruk for å bekjempe forstyrrelsen har antatt voldsomme proporsjoner. Lege Charlotte Lunde skriver i sin artikkel i Samtiden nr. 3/2011: Fra hyperaktiv til sentralstimulert – Et essay om barnedoping, at omsetningen av ADHD-medisiner i Norge har steget fra 4 til 184 millioner kroner i løpet av elleve år. Over 17500 barn¹ står nå på ADHD-medisiner. Det fagfolk etter min mening har mistet øye for, er at barn med en høy aktivitetsgrad, og manglende impuls kontroll, ofte lever under vanskelige livsutfordringer. Høy grad av aktivitet, oppmerksomhetssvikt og manglende impuls kontroll er ikke medisinske problemer- de henger mer sammen med for sterke livsutfordringer! ADHD som diagnose kan bero på en feil erkjennelse; ADHD blir betegnet som en sykdom uten utforskning og inkludering av barnets livsomstendigheter. Da får man en alt for ensidig diagnosesetting! Gjennom manglende fokus på helhet, står man i fare for å omdøpe vanlige livsutfordringer til iboende avvik og sykdom hos barnet. Spørsmålet reises; er ADHD en sykdom, en sosialkonstruksjon eller både/og?

Af Luuk L. Westerhof. Master i helsefremmende arbeid og klinisk spesialist i familierapi. Ekstern foreleser ved Høgskolen i Østfold, Norge.

Villfarelse ...?

Globalt er det et stadig økende antall fagfolk som mener at det er en villfarelse at ADHD (Attention Deficit/Hyperactivity Disorder) er relatert til en mangeltilstand eller kjemisk ubalanse i hjernen. Dessverre er det mange barn som blir diagnostisert på grunnlag av denne villfarelse og står dermed i fare for å bli (feil) medisinerert (Frances, 2013; Gøtzsche, 2015; Whitaker, 2010a, 2015). Det er en økende bevisst-

het om, at det er den farmasøytiske industrien som profitterer på dette (Frances, 2013; Gøtzsche, 2015; Whitaker, 2010a, 2010b, 2015). Den farmasøytiske industri vil ha oss til å tro at det finnes en kjemisk ubalanse i hjernen som påvirker utviklingen av ADHD, og at barn derfor trenger medisiner. Pr. i dag, foreligger det ikke tilstrekkelig forskning som kan støtte opp om en slik påstand (Frances, 2013; Whitaker, 2010a, 2010b, 2015). Mange innen fagfeltet hevder at det ikke er noen sammenheng mellom ADHD og kjemisk avvik i hjernen, og at det ikke

1 Begrepet barn og unge blir brukt om hverandre.

er noen hjerneområder som er mindre enn de bør, eller er underutviklet (Breggin, 1991, 2008; Stein, 1999; Whitaker, 2010a, 2015).

Fremfor å forklare barnets ulike fremtredelsesformer kategorisk som atferds avvik (Hertz & Glomnes, 2011) og -eller som sykdom, tar jeg til orde for at vi heller bør innta en mer nysgjerrig antropologisk utforskende attityde. Dette, for å se om ADHD også kan betraktes som en sosial konstruksjon; et fenomen som ikke primært oppstår i hodet til et individ, men i høy grad blir til i prosessene *«imellom»* hodene. Jeg mener at en postmoderne sosialkonstruksjonistisk og språkssystemisk tilnærming, kan være mer egnet som forståelsesramme i vår bestrebelse på å forstå ADHD (Anderson, 1997; Anderson & Gehart, 2007; Davis & Gergen, 1985; Gergen, 2015).

Den postmoderne tilnærmingen tar i større grad høyde for at et hvert individ er en ressurs og unik. ADHD blir således mer forstått som en ansamling og uttrykk av virkninger av pågående interpersonelle prosesser innenfor sosiale kontekster av uorden. Vi må derfor være påpasselig med å ikke tilskrive annerledes atferd oppstått innenfor kontekster av sosial uorden som individuelle skavanker (Hertz & Glomnes, 2011). Fra et sosialkonstruksjonistisk perspektiv kan kontekster av sosial- og relasjonell uorden forstås som en katalysator for utvikling av ADHD-lignende fremtredelsesformer. Således vil ADHD fra et postmoderne perspektiv kunne tolkes som en språklig benevnelse for en annerledes atferd. Vil en slik tilnærming kunne bidra til en reduisering av barn som sendes til utred-

ning, diagnostisering og med det fare for (feil-) medsisinering?

For snar henvisningspraksis?

Barn som utviser en annerledes måte å oppføre seg på enn det som forventes, blir som regel, alt for ofte, og alt for raskt, henvist for utredning til for eksempel psykolog og BUP (barne- og ungdomspsykiatri). Utfallet av en slik henvisningspraksis fører som regel til gjennomføringen av standardiserte tester og, en etter min mening, for rask diagnosesetting. Disse testene kan stå i fare for å fremstå som *«frosne»* ord (Andersen, 2005): de kan lett oppleves av barnet som uten mål og mening der *«frosne»* standardiserte spørsmål som regel ikke evner å treffe det levde livet hvert barn er unik, har sine unike utfordringer og *«one size doesn't fit all»*. Jeg mener at den nåværende henvisningspraksis har bidratt til den eksplosive utviklingen av barn som er diagnostisert med ADHD. Psykiater Allen Frances skriver at det gjennomsnittlig tar 7 minutter i konsultasjon hos psykiater i USA for å få en diagnose- han kaller dette for en diagnostisk inflasjon (Frances, 2013). Det jeg er nysgjerrig på er hvordan en diagnose så lett kan settes, uten at man i tilstrekkelig grad hører på barna; deres livserfaringer, utfordringer i livet, og livshistorie.

Psykiater Sam Timimi, som er tilknyttet det engelske folkehelseinstituttet, mener at det moderne vestlige samfunnet skaper en form for stress for dagens barnefamilier, som igjen kan gi utslag i ADHD-symptomer (Timimi, 2005; Timimi & Leo, 2009). Kan ADHD være en fiktiv epidemi? Sir Ken

Robinson mener at dette er tilfelle (Lunde, 2011).

Kan det være mer fruktbart å ha et mer sosialpedagogisk fokus på barnets ytre miljø, enn et nevrobiologisk fokus på barnets indre? Vi må se barn som individer og som en del av ulike kontekster: familien, skole, foreninger, ste-familie osv! Barn blir alt for ofte betraktet som bærer av en iboende mangeltilstand (deficit) som må behandles eller medisineres (Frances, 2013; Gøtzsche, 2015; Hertz & Glomnes, 2011; Whitaker, 2015). Vil en slik tilnærming ekskludere ekspertise og bistand fra leger, nevropsykologi, psykologer og lignende? Nei, jeg tenker at det ikke kan være et «enten-eller». En «enten-eller» dikotomi vil være reduksjonistisk og dermed uproduktiv, siden den legger opp til maktkamper om hva som er rett eller galt, riktig eller feil, godt eller vond. Vi bør heller omfavne en «både-og» tilnærming som mer åpner opp for tanken om at ADHD kan ha flere tilblivelsesformer. Jeg mener at dette er et viktig perspektiv å ta med seg; ikke all ADHD er *kun* et fenomen oppstått innenfor sosiale kontekster av uorden. ADHD handler om både arv og miljø, i varierende grad. Hos noen barn kan det være en sterk grad av arvelighet. Å anlegge en «både-og» tenkning gjør det også enklere å omfavne og å nyttiggjøre seg de profesjonene i hjelpeapparatet som kan være nyttig for barnet som strever. Jeg tenker her på familieterapeut, sosialpedagog, psykolog, lege, psykiater, klasselærer og lignende. Den Norske sosial psykiater Tom Andersen (Andersen, 2005) poengterte at det var viktig med å høre flere stemmer, slik at vi be-

dre kunne forstå et fenomen. En «både-og» tenkning vil kunne åpne for en omfavnelser av et slikt perspektiv i hvordan vi bør jobbe med barn som strever med ADHD.

Om vi kun forstår ADHD fra en postmoderne sosialkonstruksjonistisk tilnærming, kan vi stå i fare for å overse de barna som har en ADHD av primært arvelig form. Som fagperson må vi gjerne ha en forkjærlighet for en bestemt hypotese eller paradigme, men vi bør vakte oss for å bli alt for glad i disse, for det kan føre til 'blind' ekskludering av andre, også nyttige tilnærminger (Cecchin, Lane, & Ray, 1994; Cecchin, Lane, Ray, & Keeney, 1992; Selvini, Boscolo, Cecchin, & Prata, 1980).

Dessverre har den etter min mening for snare henvisningspraksis ført til at ADHD har blitt den diagnose med høyest prevalens i barnebefolkningen. (Frances, 2013). ADHD er den hyppigste grunnen til at barn blir henvist til hjelpeapparatet, og skoler og barnehauger er sterkt involvert når det gjelder diagnostisering av ADHD (Lunde, 2011). Sammen med Lunde spør jeg om normal småbarns – atferd blir medisinert for å få ro i klasserommet? I kjølvannet av den økende ADHD prevalensen øker medisinbruken. FN er bekymret over denne voldsomme utviklingen av ADHD-medisinering på barn i Norge. På ti år har det vært en ti-dobling i bruk av ADHD-medisin, og nå ligger Norge i verdenstoppen. Norge er det landet i Europa som følger USAs utvikling og har det høyeste forbruket av medikamentell behandling av ADHD (www.fmr.no).

Arv og Miljø

I dag besitter vi en mengde kunnskap om epigenetikk. Epigenetikk er læren om hvorledes gener forandres uten at selve DNA i kjernen forandres, hvordan gener “skrues av og på», og viser at arvelige egenskaper kan modifiseres f.eks. av kjønn. Det er godt dokumentert at vår fenotyp (hva som kommer til uttrykk) er summen av arv og miljø-betingelser (sml.snl.no/epigenetikk)). Ingen er med andre ord bare arv eller bare miljø. Selv arvelige egenskaper varierer sterkt i hvordan de kommer til uttrykk i det enkelte menneske. ADHD som diagnose vil derfor alltid være et resultat av dette samspillet. Siden den genetiske komponenten i liten grad kan fastslå ADHD eksakt, aktualiserer dette viktigheten av godt skrevne anamneser som i større grad kan gi innblikk i barnets totale livsbelastninger og livsutfordringer.

Medfødt sårbarhet; “en hvilken som helst faktor hos individet eller i oppvekstmiljøet som kan assosieres med økt sannsynlighet for negativ psykososial utvikling i fremtiden» En beskyttelsesfaktor er “en hvilken som helst faktor hos individet eller i oppvekstmiljøet som kan assosieres med redusert sannsynlighet for fremtidig negativ psykososial utvikling» (Gravrok, Knudsmoen, Larsen, Nordahl, og Rørnes, 2005) Medfødt sårbarhet kan utløse faktorer så som rastløshet, impulsivitet og uoppmerksomhet eller en kombinasjon av disse og være med på å opprettholde faktorer så som distraksjon i klasserommet eller hjemme. Jeg tenker på linje med psykologspesialist Espen Idås (spesialist i barne- og ungdomspsykologi) at ADHD kan forstås

på ulike måter. De observerbare symptomene til ADHD kan være like, men hvor symptomene tillegges forskjellige årsaker og forklaringer. Jeg tenker at en slik tilnærming til barn som strever med ADHD vil kunne være mer fruktbar og nyttig. Noen av utfordringen ligger i de utallige symptomkombinasjoner ved ADHD; for eksempel et vedvarende mønster av uoppmerksomhet, hyperaktivitet, impulsivitet, eller en kombinasjon av alle tre. Ved så mange mulige symptomer og mulige kombinasjoner av symptomer, blir feildiagnostisering både sannsynlig og prevalent (forekommende). Det som gjør eksakt diagnostisering så vanskelig for å ikke si umulig, er at det finnes mange inklusjonskriterier, men få tydelige eksklusjonskriterier. Det betyr at uansett årsak, dersom man har symptomene, så kan man stå i fare for å få diagnosen ADHD, selv om symptomene burde vært forstått som sunne responser på usunne livsbelastninger, og hvor diagnosen således skulle vært noe annet enn ADHD. Dette ville følgelig ha ført til andre forståelser og andre tiltaks- og behandlingsplaner.

Å anlegge en slik forståelse av ADHD vil kunne forebygge at barn som strever med utfordringer i livet blir feilaktig medisinerert med for eksempel Metylphenidat (Concerta, og Ritalin). I mange tilfeller er medisineren en uetisk løsning på et problem som like gjerne kan ha sin forklaring i barnets oppvekstmiljø som i nevrologiske forhold hvor medisinen er løsningen. For at barnet på best mulig måte kan bli sikret adekvat og kyndig hjelp, tar jeg til orde for en bred tverrfaglig tilnærming i kartleggings- og behandlingsprosessen. En bred

tverrfaglig tilnærming vil etter min mening kunne gi en grundigere innblikk i «hva som er hva»; er det arv, miljø, livsutfordringer, livsbelastninger eller en kombinasjon av dem ...? En bred tverrfaglig utviklingsorientert tilnærming vil også kunne være med på å bremse opp for de stigende diagnostiserings – tendenser. Kan det å anlegge en slik bred tverrfaglig tilnærming være med på å øke forståelse for at ADHD ikke har kun én årsak ...? Jeg tenker i hvert fall at vi som fagpersoner må insistere på at samspill mellom mennesker alltid må ses i lys av kulturelle og samfunnsmessige fenomener: en bred tverrfaglig tilnærming kan sikre at dette perspektiv blir anlagt i arbeid rundt barnet.

ADHD som Atferdsproblem

Fremfor å anse ADHD som en iboende mangeltilstand (deficit) og atferdsproblem, kan vi kanskje begynne å betrakte det som annerledes atferdsmessige ytringer -sunne responser til usunne tilstander- men som av samfunnet oppleves som problematisk: Ser vi et barn med atferd som innfrir negative forventninger, eller ser vi et barn som har en sunn respons på usunne livsbetingelser? Kan å betrakte ADHD fra denne vinklingen gjøre det mulig å akseptere at barn gjennom sin annerledes fremtredelsesformer viser det beste de har å by på i enhver omstendighet og til enhver tid (Hertz & Glomnes, 2011)? Kan det å forstå ADHD på denne måten åpne opp for en mer kontekstuell og relasjonell forståelse? Mennesker er født som en del av sosiale nettverk og er således en del av dets sosiale relasjoner, sosial samhandling og språk. Nettverk forbinder mennes-

ker ved at de sosialt og psykologisk samhandler med hverandre via språk og sosial aktivitet. ADHD kan fra dette perspektiv forstås som en atferdsmessig ytring som ikke betraktes som ett problem men som en fenotype som er sammensatt av mange forskjellige biopsykososiale determinanter. Fremfor å snakke om «barn som er annerledes», kan vi heller begynne å si noe annet, nemlig: «et annerledes barn». En slik tilnærming kan åpne opp for en mer refleksiv tilnærming- vi kan begynne å stille oss spørsmål som: 'Hva er det som gjør dette barn annerledes?' Er det noe i barnets sosiale omgivelser som fører til annerledes atferd enn forventet? Og slik Tom Andersen sa, *du kan kun endre deg selv* (Andersen, 2005), så er det kanskje på tiden at den enkelte fagperson begynner å tenke og gjøre noe annerledes. Fremfor å henvise barnet til utredning for raskt til psykolog, BUP osv. kan vi heller forsøke å komme i dialog med barnet.

Kan det å møte barn fra et biopsykososial perspektiv bidra til at deres behov for å opptre annerledes reduseres? Kan annerledeshet i form av dialog fremfor diagnose bidra til at fagpersonen får øye på det som bør ses? Det som bør ses blir for ofte oversett, fordi man er for opptatt med å se mangler fremfor uante muligheter? (Hertz & Glomnes, 2011).

Jeg mener at vi i bør avstå fra å spørre om hva som er galt *med* barnet og heller spørre *hva* galt har hendt *med* barnet. Å stille dette spørsmålet som en respons på barnets annerledes framferd, kan gi meningsfulle svar. En forutsetning er selvsagt at fagpersonen kommer i god dialog med barnet. Det

er ingen tvil om at enkelte barn har en type uro og konsentrasjonssvikt som er fundert på et nevrologisk grunnlag. Heller er det ingen tvil om at man finner tilsvarende problemer hos barn som lider under utilstrekkelig omsorg eller i familier preget av disharmoni (Ladnier & Massanari, 2000). Med dette tar jeg til orde for en større rolle og anvendelse av førstelinjetjenestene, som også lettere kan gi bistand til foreldre, barnet, skole osv. uten at det må settes en diagnose. Dette kan være kostnadseffektivt, mens psykiatrisk diagnostikk som regel er kostnadskreven.

Ulike paradigmer

Det finnes ulike paradigmer som kan anvendes i å forstå ADHD. I 2006 inviterte den Norske psykologforening til debatt om anvendelsen av ADHD diagnosen på barn som strever med uro og konsentrasjon. Fire fagpersoner presenterte sitt faglige ståsted relatert til ADHD. Psykolog spesialist Espen Idås (2006) etterlyste testinstrumenter som kunne skille mellom utilstrekkelig omsorg eller oppvekst i disharmoniske familier samt konsentrasjonssvikt som kunne forklares ut i fra et nevrologisk perspektiv. Idås gav uttrykk for en bekymring med tanke på den økende bruken av medikamenter i behandling av barn som angivelig skulle streve med ADHD. Per Are Løkke (psykolog) fremhevet at ADHD diagnosen er mer basert på atferds- beskrivelser (2006), og gir uttrykk for tanke om at atferden like godt kan skyldes traumer, oppdrags- relasjonsforhold, temperament eller naturlig variasjon. Løkke (2006) opponerer mot den biomedisinske syk-

domsforståelsen av ADHD og mener at diagnosensmanualens klassifisering og objektivering tillegges for stor makt. I tillegg er han kritisk til den medisinske ensprogethet av forskning, standardiserte behandlingsmetoder, og en urovekkende økende bruk av medikamentell behandling. Dette er en bekymring som deles av blant annet Robert Whitaker (vitenskaps journalist) (Whitaker, 2010a, 2010b, 2015), Psykiater Allen Frances (leder for DSM-IV arbeidsgruppe) (Frances, 2013), og Peter C. Gøtzsche (psykiater og leder for Cochran forskningscenter i Danmark) (Gøtzsche, 2015). I 2006 gav professor Lars Smith ved psykologisk institutt (UIO) uttrykk for at han langt på vei støttet kritikken fra Løkke og Idås og manet til debatt om bruken av ADHD diagnosen. Smith mener at både nevr- ale og biologiske faktorer kan innvirke på psykologiske prosesser, men også at psykologiske og sosiale prosesser kan innvirke på strukturer, funksjoner og organisering av hjernen, samt påvirke barnets genetiske uttrykk (jf. Cicchetti & Tucker, 1994; Nelson & Blom, 1997, ref. i Smith, 2006). På bakgrunn av den gjensidige påvirkning mellom genetiske, nevr- ale, atferdsmessige og miljømessige faktorer i livsløpet, understreker Smith viktigheten av godt skrevne anamneser.

Barnepsykiatri er i en økende grad influert av resiliens-forskning. Resiliens forskning er knyttet til Anton Antonovskys (1979, 2008, 2012) sine teorier om salutogenese. Salutogenese har et medisinsk perspektiv som fra et kontinuum tilnærming søker å forklare utvikling av god helse, i motsetning til patogenese, som forklarer sykdom (A.

Antonovsky, 1979; Aaron Antonovsky & Mortensen, 2008; Aaron Antonovsky & Sjøbu, 2012). Antonovsky legger vekt på 3 komponenter: Forståelse, håndterbarhet og mening. I disse 3 komponentene ligger ”opplevelse av sammenheng” (sense of coherence), og det finnes en intern rangering, der mening er den mest sentrale, og en forutsetning for forståelse og håndterbarhet for det som inntreffer. Forståelse ses på som en opplevelse av orden, struktur og tydelighet. Med håndterbarhet menes at et menneske sitter med en opplevelse av å ha tilstrekkelig med ressurser for å kunne møte ulike situasjoner i og utfordringer livet. Med meningsfullhet menes at et menneske sitter på en opplevelse av delaktighet i det som skjer. Antonovsky mener at dette styrker evnen til å takle problemer og opplevelser bedre enn en person som har en lavere opplevelse av sammenheng og beholde en psykisk styrke og helse til tross for stress og påkjenninger. Å være resiliert vil si at man er robust. Av individuelle egenskaper står optimisme, god selvfølelse, sosiale evner og at man er kreativ og har interesser, sentralt. Av kontekstuelle forhold står familiens ressurser, nettverk og støttende forhold i skole og nærmiljø sentralt. (Store norske leksikon på nett, snl.no, 2010).

Klistermerke eller Individ?

Mange barn har blitt bærer av en ADHD klistermerke, et klistermerke som barn får gjennom en diagnose, og som kan være mer skadelig enn det man kanskje er klar for å innrømme? Klistremerker er som regel identitets-skapende (Hertz & Glomnes, 2011).

Det som er foruroligende med klistermerkens makt, er at barn får et budskap om at de er ‘eier’ av problemene. En ADHD -diagnose kan lett blir et klistermerke som formidler tanken om at det er noe galt med barnet: barnet er årsaken til ...? Dette mener jeg er en absurd problemtilskrivning og uttrykk for omgivelsenes ansvarsfraskrivning. Omgivelsene lukker øynene for hvordan de er med på å skape vanskelige livsomstendigheter for barn som opplever mestringsvansker. Det vil etter min mening være mer riktig å snakke om barn som står ‘i’ livsutfordringer fremfor å snakke om barn som individer ‘med’ problemer. Dette vil være en mer fruktbar retorikk, enn å snakke om problembarn. Kan en slik betraktning av barn som strever bidra til et mer nyansert bilde av barn som individer i møte med vanskelige livsutfordringer? Vil en slik tilnærming kunne forebygge en for rask diagnostisering, sykeliggjøring og medisinerings? Svaret på disse spørsmålene ligger ikke ‘i’ det enkelte individet, men heller ‘imellom’ individene- det dialogiske rommet! Som fagpersoner bør vi bestrebe oss på å tilrettelegge for dialoger hvori barn kan snakke om hva som gjør at de opptrer annerledes enn forventet fremfor å holde fast på myten om at barnet ‘er’ annerledes: vi bør bidra til at barn ikke trenger å bære korset alene!

Et korrumpert belønningssystem?

Den farmasøytiske industrien inntar en meget tvilsom rolle med tanke på den eksplosive utviklingen av ADHD-diagnosesettingen (Frances, 2013; Gøtzsche, 2015; Whitaker, 2010a,

2010b, 2015). Den farmasøytiske industrien, eller som vitenskapsjournalist Robert Whitaker og psykiater Allen Frances kaller det, «Big Pharma» (Frances, 2013; Whitaker, 2015) er tjent med at det settes ADHD diagnoser. Dette stimulerer og fremmer salget av ADHD-medisiner så som Ritalin, Adderal, Concerta, Equasym og Medikinet.

Psykiatrien legger etter min oppfatning til rette for en samfunnsrettet informasjonsstrøm som insinuerer at ADHD er en neurobiologisk hjernesykdom. Den farmasøytiske industrien markedsfører og promoterer ADHD således i stor skala. Etter min forståelse er Big Pharma sin promotering av ADHD som neurobiologisk skavank farlig der den hentyder til, og fremstiller barnets forsøk på mestring av livsutfordringer og hvordan dette ytrer seg, som en iboende neurologisk lidelse. Den farmasøytiske industri lager websider, de belønner leger og psykiatere som rekvirere ADHD-medisin og de søker etter å få innpass i ulike formelle og uformelle sosiale samfunnsarenaer så som foreldreforeninger- den farmasøytiske industrien er nær sagt overalt! Markedsføring fra farmasøytisk industri påvirker legers forskrivning av medikamenter. En studie fra 2004 viste at bare rundt halvparten av påstandene i skriftlig legemiddelreklame var korrekte og klinisk relevante (Helsemagasinet, 2015). Det som bør være en stor tankevekker, er at den farmasøytiske industrien bruker to ganger så mye penger på markedsføring av deres produkter enn det de gjør på utviklingen av dem (Götzsche, 2015). Med andre ord, vi trenger en

større etisk refleksjon omtrent medisineringen i psykiatrien generelt, og medisinering av barn spesielt.

En større ærlighet rundt medisinering

Det er for lite bevissthet rundt dagens storstilte medisinering av barn. I 2013 fikk 16 878 barn og unge under 18 år i Norge medisinering etter å ha fått diagnosen ADHD. 72 prosent var gutter (Nordahl, 2015). Det har lenge vært en økning i medisinering av personer med ADHD. Med dette betyr jeg ikke at medisinering ikke er nyttig, for det kan det være. Mitt anliggende er derimot at fagpersoner bør bli mer reflektert og kritisk på medisinering av barn. Medisinering bør være den siste utvei og ikke det første alternativet. Dette betyr at det må foretas en refleksjon og revurdering om hva en kan oppnå ved bruk av ADHD-medisiner, og veie dette opp mot ulemper, ikke minst hva disse medisiner kan gjøre med barns nevrologisk på lang sikt.

ADHD-medisiner har den funksjon at det undertrykker forskjellige former for atferd. De forbedrer ikke skoleprestasjoner og de endrer heller ikke sosial atferd. Men er det noen som virkelig vet eller forstår om de langsiktige effektene av ADHD medisiner? Det er gjort studier for å fastslå langtidseffekten av å bruke ADHD medikamentene. Det er reist bekymring om langtidseffekter av disse medikamentene. Noen mener at bruk av Ritalin kan ha mulige effekter på barns utvikling av hjernen. Noen frykter også at langvarig bruk av ADHD -legemidlene kan føre til annet rusmisbruk når barnet blir eldre. Psykiatriske problemer kan også

oppstå, som depresjon, angst og aggresjon. Manglende kunnskap omkring langtidseffekten bør i seg selv være grunnlag nok for å redusere AD-HD-medisinering til det minimale. Medisinering har ikke kun fysiske virkninger, den har også psykologiske implikasjoner. ADHD-medisinering av barnet kan bidra til at barnet begynner å tro at han er opphavet til alle problemene. På denne måten kan AD-HD-medisinering medvirke til en feilslått identitetsdanning hos barnet (Hertz & Glomnes, 2011). I tillegg har ADHD-medisinering kjente bivirkninger så som mavesmerter, kvalme, søvnproblemer, hodepine. Som regel blir disse bivirkninger bagatellisert. Ofte blir det sagt at bivirkninger forsvinner etter noen uker, noe som ikke er riktig i de fleste tilfeller.

Respektfylt lytting og vennlige stemmer som alternativ

Barn som ytrer seg gjennom 'annerledeshet' er ikke nødvendigvis syke. Fagpersoner bør etter min mening heller bestrebe seg på å lytte mer respektfylt til barnet. Respektfylt lytting innebærer blant annet at barnet blir tatt på alvor. Dette kan bidra til barnets opplevelse av en normalisering og anerkjennelse for dets intersubjektive opplevelsesverden. Å lytte mer respektfylt til barnet, betyr også at vi leter etter rom for alternative og mer 'vennlige stemmer' (Penn & Frankfurt, 1994). Hverken familier eller barn *er* på bestemte måter. Alle endrer seg kontinuerlig. I noen perioder kan et barn virke kaotisk, i andre tilfeller; frakoblet. I noen kontekster

kan barn oppleve seg isolert, mens i andre sammenheng; sosial. Som fagperson bør vi unnlåte å sette statiske klistermerker på barn, og heller tillate samarbeidsformer med barnet og dets familie, om hvordan de kan betrakte og leve sitt liv på en annerledes måte. Kan vi gjennom mer vennlige stemmer og respektfylt lytting i samtale med barn bidra til en større normalisering av barns bestrebelser på mestring av livet? Kan mer vennlige stemmer og respektfylt lytting bidra til en økt opplevelse av anerkjennelse for barnets ærlige forsøk på å mestre livsutfordringer i hverdagen? Når barn og foreldrene opplever seg hørt og sett, kan motstand reduseres og rom for dialog og mer vennlige stemmer fremtre.

Referencer

- Andersen, T. (2005). *Reflekterende prosesser : samtaler og samtaler om samtalerne* (3. udgave. ed.). Virum Køge: Dansk Psykologisk Forlag ; eksp. DBK.
- Anderson, H. (1997). *Conversation, language, and possibilities : a postmodern approach to therapy*. New York, N.Y.: BasicBooks.
- Anderson, H., & Gehart, D. (2007). *Collaborative therapy : relationships and conversations that make a difference*. New York: Routledge.
- Antonovsky, A. (1979). *Health, stress and coping*. San Francisco,.
- Antonovsky, A., & Mortensen, K. M. (2008). *Helbredets mysterium : at tåle stress og forblive rask*. Vejen: KLO.
- Antonovsky, A., & Sjøbu, A. (2012). *Helsens mysterium : den salutogene modellen* (2. oppl. ed.). Oslo: Gyldendal akademisk.
- Breggin, P. R. (1991). *Toxic psychiatry : why therapy, empathy, and love must replace the drugs, electroshock, and biochemical theories of the "new psychiatry"* (1st ed.). New York: St. Martin's Press.
- Breggin, P. R. (2008). *Brain-disabling treatments in psychiatry : drugs, electroshock,*

- and the psychopharmaceutical complex (2nd ed.). New York: Springer Pub.
- Cecchin, G., Lane, G., & Ray, W. A. (1994). *The cybernetics of prejudices in the practice of psychotherapy*. London: Karnac Books.
- Cecchin, G., Lane, G., Ray, W. A., & Keeney, B. P. (1992). *Irreverence a strategy for therapists' survival Systemic thinking and practice series* (pp. xi, 82 p.).
- Davis, K. E., & Gergen, K. J. (1985). *The social construction of the person*. New York: Springer.
- Frances, A. (2013). *Saving normal : an insider's revolt against out-of-control psychiatric diagnosis, DSM-5, Big Pharma, and the medicalization of ordinary life* (1st ed.). New York, NY: William Morrow.
- Gergen, K. (2015). *An invitation to social construction* (3. ed.). Los Angeles: Sage Publications.
- Gøtzsche, P. C. (2015). *Dødelig psykiatri og organisert fornektelse*. Oslo: Abstrakt forl.
- Hertz, S., & Glomnes, J. J. (2011). *Barne- og ungdomspsykiatri : nye perspektiver og uante muligheter*. Oslo: Gyldendal akademisk.
- Penn, P., & Frankfurt, M. (1994). Creating a participant text: writing, multiple voices, narrative multiplicity. *Fam Process*, 33(3), 217-231.
- Selvini, M. P., Boscolo, L., Cecchin, G., & Prata, G. (1980). Hypothesizing--circularity--neutrality: three guidelines for the conductor of the session. *Fam Process*, 19(1), 3-12.
- Stein, D. B. (1999). *Ritalin is not the answer: a drug-free, practical program for children diagnosed with ADD or ADHD* (1st ed.). San Francisco: Jossey-Bass.
- Timimi, S. (2005). *Naughty boys : anti-social behavior, ADHD and the role of culture*. New York: Palgrave Macmillan.
- Timimi, S., & Leo, J. (2009). *Rethinking ADHD : from brain to culture*. Basingstoke England ; New York: Palgrave Macmillan.
- Whitaker, R. (2010a). *Anatomy of an epidemic : magic bullets, psychiatric drugs, and the astonishing rise of mental illness in America* (1st ed.). New York: Crown Publishers.
- Whitaker, R. (2010b). *Mad in America bad science, bad medicine, and the enduring mistreatment of the mentally ill* (pp. 1 online resource (xviii, 348 p). Retrieved from http://getit.tat.duke.library.duke.edu/?sid=ser-sol&SS_jc=TC0000439214&title=Mad%20in%20America%20%3A%20bad%20science%2C%20bad%20medicine%2C%20and%20the%20enduring%20mistreatment%20of%20the%20mentally%20ill
- Whitaker, R. (2015). *PSYCHIATRY UNDER THE INFLUENCE : INSTITUTIONAL CORRUPTION, SOCIAL INJURY, AND PRESCRIPTIONS FOR REFOR*. New York: PALGRAVE MACMILLAN.

Internetsider:

<http://www.fmr.no/norge-paa-europatoppen-i-adhd-medisinerings308410-9431.html>
www.adhdfraud.com
<https://sml.snl.no/epigenetikk>

Har du spørsmål til artiklen, kan Luuk L. Westerhof på denne mail-adresse: luukwester@hotmail.no